



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
UNIT *INTENSIVE CARE UNIT*
(ICU)**

TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**PROGRAM KERJA UNIT ICU
RSPH SUKOREJO TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Umum / Latar Belakang

Pengembangan RS Prima Husada Sukorejo adalah salah satunya dengan adanya ruang *Intensif Care Unit* (ICU) yang memiliki kapasitas 12 tempat tidur terdiri dari 10 tempat tidur non isolasi dan 2 tempat tidur isolasi. Dalam hal ini tentunya demi tercapainya visi misi rumah sakit maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, selain itu juga harus didukung dengan faktor-faktor lainnya.

Besar harapan kami dengan adanya program peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan faktor lainnya maka pasien-pasien khususnya di ruang *Intensif Care Unit* (ICU) dapat terlayani dengan baik, cepat, tepat, dan akurat sehingga angka kematian dapat ditekan seoptimal mungkin. Pada tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terealisasi dengan baik, seperti *In House Training* atau seminar dan workshop diluar rumah sakit atau tentang sarana prasarana di unit ICU yang belum sesuai dengan standart.

Sebagai salah satu layanan kesehatan, RS Prima Husada Sukorejo juga dilengkapi dengan ruangan yang diperuntukan untuk pasien dengan kondisi kritis. Secara umum, ruang ICU adalah ruang rawat di rumah sakit yang dilengkapi dengan staff dan peralatan khusus untuk merawat dan mengobati pasien yang terancam jiwa oleh kegagalan atau disfungsi organ atau ganda akibat bencana, penyakit atau komplikasi yang masih ada harapan hidupnya (reversible).

Perawat sebagai pelaksana pemberi asuhan keperawatan pada pasien di Unit Kritis harus mampu memiliki kemampuan pengetahuan, ketrampilan, sikap, cekatan, tepat, cepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi, juga harus mampu mengoperasikan alay-alat khusus yang ada di ICU.

Mengingat 6 sasaran keselamatan pasien yang menjadi konsentrasi bagi kita untuk terus dicapai dan dipertahankan maka menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kerja ini semuanya bisa tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan serta waktu yang telah ditentukan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan..
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.
5. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024.
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Program Kerja *Intensif Care Unit* disusun sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan intensif yang bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh tenaga kesehatan di *Intensif Care Unit* dalam melaksanakan tugas secara terstandar, memenuhi ketentuan regulasi, serta mendukung pencapaian visi dan misi rumah sakit.

1.3.2 Tujuan Umum

Tercapainya rasa aman dan nyaman untuk pasien, pengunjung, dan karyawan melalui sarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi syarat dan diharapkan fungsi pelayanan kita bisa memenuhi standar pelayanan pasien yang sudah ditentukan

1.3.2 Tujuan Khusus

Terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1. Menyelenggarakan pelayanan Unit Intensive yang berkualitas sesuai dengan standar yang ada.
2. Tercapainya SDM sesuai kualitas dan kuantitasnya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Unit Intensive di Rumah Sakit Prima Husada agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan medik.
4. Memastikan agar peralatan di Unit Intensive dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan unit intensive.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

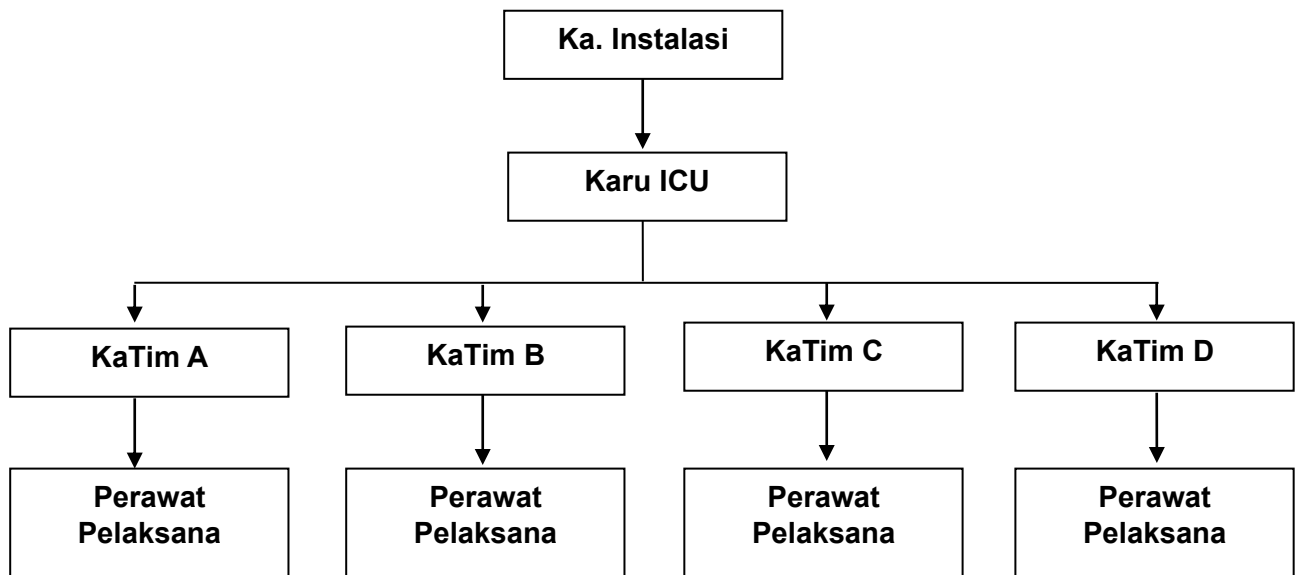
2.3 Motto Unit

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Unit



BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Meningkatkan SDM ICU	1) Menghitung Kebutuhan SDM 2) Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru 3) Membuat Penilaian Kinerja staf 4) Melaksanakan Diklat Terkait Akreditasi (Mengikuti SDM) 5) Melaksanakan Diklat ICU (Mengirimkan 2 staf ke RSSA)
2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien ICU	1) Melakukan Personal Higiene 2) Melakukan Asuhan Pasien 3) Melakukan Tindakan Kegawatan di ICU 4) Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien 5) Melakukan Pelayanan Psiko, Culturo Spiritual
3	Pengembangan Pelayanan	Ruang tunggu Khusus Keluarga pasien ICU dilengkapi dengan speaker portable
4	Melaksanakan MFK-K3	1) Melaksanakan Pemeliharaan sarana ICU (Bangunan) 2) Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana ICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi aldok/alkes) 3) Melaksanakan Penambahan alat baru 4) Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Melakukan MCU
5	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di ICU (PMKP)	1) Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a) Kepatuhan Identifikasi Pasien b) Kepatuhan Kebersihan Tangan c) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh d) Kepatuhan Visite Dokter Spesialis (07.00 – 14.00) e) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 2) Pengukuran Indikator Mutu Prioritas RS kepatuhan pada semua indikator SKP (6 item) a) Identifikasi Pasien Dengan Benar b) Komunikasi Efektif c) Peningkatan Keamananobat Yang Perlu Diwaspadai d) Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Dan Pasien Yang Menjalani Tindakan Dan Prosedur e) Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan f) Pengurangan Resiko Jatuh 3) Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit : a) Angka Pasien Kembali Ke Perawatan Intensive Dengan Kasus Yang Sama < 72 jam b) Kepatuhan Pengisian Pengkajian Form Kriteria Keluar Masuk ICU Pada Pasien ICU c) Kepatuhan Perawat Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR
6	Melaksanakan program PPI di ICU	1)Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah



		d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus 2) Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi
7	Melaksanakan program PKRS	1) Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga (100%) 2) Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl) 3) Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial) 4) Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. ICU
8	Melaksanakan MONEV	1) Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk 2) Melaksanakan Rapat Unit 3) Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program
9	Membuat laporan	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)

3.2 Sasaran

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Meningkatkan SDM ICU						
1)	Menghitung Kebutuhan SDM	Memenuhi kebutuhan SDM ICU	Karu	SDM	Per bulan	Terdapat dokumen usulan kebutuhan (setelah melakukan perhitungan)	
2)	Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru	Mengenalkan tugas kepada staf baru	Jika ada staf baru	SDM	Tergantung SDM	Terdapat Form Penilaian staf orientasi yang telah dibuat	
3)	Membuat penilaian Kinerja Staf	Mengevaluasi hasil kinerja harian staf	All Staf	Evaluasi Kinerja	1 th 1x (data tiap bln)	Terdapat dokumen penilaian kinerja all staf (yg tdd: Uraian tugas dan mutu yang diukur di unit ICU tiap hari dipantau)	
4)	Melaksanakan Diklat terkait akreditasi	Peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan pelayanan dan kompeten di ICU	All Staf	Internal	100%	Sertifikat	
5)	Melaksanakan Diklat ICU (Mengirimkan 2 staf ke RSSA)		1. Sumikatul Zannah, AMd.Kep, Ns. 2. Wahyulan Masruroh, S.Kep, Ns. Feby	Eksternal	100%	Sertifikat	
2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien ICU						
1)	Melakukan Personal Higiene	Memenuhi Kebutuhan Dasar Pasien	Seluruh Pasien ICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
2)	Melakukan Asuhan Pasien	Memenuhi kebutuhan asuhan pasien di RuangICU	Seluruh Pasien ICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
3)	Melakukan Tindakan Kegawatan di ICU	Melakukan tindakan-tindakan emergency yang dibutuhkan di	Seluruh Pasien ICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	



		pada pasien ICU					
4)	Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Meningkatkan pemahaman keluarga mengenai kondisi pasien	Seluruh Keluarga Pasien ICU	Internal	Setiap hari	From Edukasi Terintegrasi	
5)	Melakukan Pelayanan Psiko, Culturo Spiritual	Menfasilitasi mengenai kebutuhan pelayanan psikologis , culturo, spiritual	Seluruh Pasien ICU	Internal	Setiap 1 minggu sekali	Form RPR	
3.	Pengembangan Pelayanan						
1)	Ruang tunggu Khusus Keluarga pasien ICU dilengkapi dengan speaker portable	Kenyamanan penunggu keluarga pasien ICU	Keluarga pasien ICU	Internal	Terpenuhi	Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman khusus untuk keluarga pasien ICU	
4.	Melaksanakan MFK-K3						
1)	Melaksanakan Pemeliharaan sarana ICU (Bangunan)	Memastikan lingkungan fisik ruang ICU dalam keadaan aman dan nyaman	Kabid Umum Tukang	Internal	Terpenuhi	Laporan Bulanan	
2)	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana ICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi aldok/alkes	Memastikan semua failitas dan alat dalam kondisi baik	IPSRS	Internal	Kalibrasi : 1 tahun Sekali	Laporan Bulanan	
3)	Melaksanakan Penambahan alat baru	Memenuhi kebutuhan alat yang masih kurang atau belum ada	Karu ICU	Internal	Terpenuhi	Tidak ada peminjaman alat ke unit lain	
4)	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset,	a) Mencegah terjadinya kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Menilai kondisi kesehatan staf	Seluruh Staf ICU	Internal	Terpenuhi	Tidak ada staf yang mengalami kecelakaan kerja File MCU seluruh staf	



	jatuh, kesetrum) b) Melakukan MCU						
5.	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di ICU (PMKP)						
1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a) Kepatuhan Identifikasi Pasien b) Kepatuhan Kebersihan Tangan c) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh d) Kepatuhan Visite Dokter Spesialis (07.00 – 14.00) e) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit , peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff ICU 2. PIC Mutu	Internal	Sesuai standart a) 100% b) 100% c) 100% d) ≥80% e) 100%	1. Melakukan sosialisasi SKP tentang identifikasi pasien 2. Melakukan supervisi karu dan PPI mengenai Hand Hiygiene 6 langkah dan 5 moment 3. Melakukan supervise karu terhadap kepatuhan resiko jatuh 4. Koordinasi kepada DPJP terkait kepatuhan waktu visite 5. Melakukan supervisi penggunaan APD yang tepat	
2)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas RS kepatuhan pada semua indicator SKP a) Identifikasi Pasien Dengan Benar b) Komunikasi Efektif c) Peningkatan Keamananobat Yang Perlu Diwaspadai d) Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Dan Pasien Yang Menjalani Tindakan Dan Prosedur e) Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan f) Pengurangan Resiko	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit , peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff ICU 2. PIC Mutu	Internal	100%	Tidak adanya IKP	



	Jatuh						
3)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit : a) Angka Pasien Kembali Ke Perawatan Intensive Dengan Kasus Yang Sama < 72 jam b) Kepatuhan Pengisian Pengkajian Form Kriteria Keluar Masuk ICU Pada Pasien ICU c) Kepatuhan Perawat Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit , peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff ICU 2. PIC Mutu	Internal	Sesuai standart a) $\geq 3\%$ b) 100% c) 100%	1. Koordinasi dengan tim dan DPJP terkait kepatuhan dalam pelaksanaan pasien kriteria keluar ICU 2. Sosialisasi dan Supervisi terkait kelengkapan pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥ 24 jam 3. Sosialisasi kelengkapan penulisan CPPT terhadap staff Rawat Inap	
6.	Melaksanakan program PPI di ICU						
1)	Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus	Tidak ada infeksi yang menular dari staf ke pasien	Seluruh staf ICU	Internal	0 kejadian	Tidak ada kejadian infeksi pada pasien yang disebabkan oleh staf	
2)	Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Tidak ada infeksi yang menular dari staf ke pasien	Seluruh staf ICU	Internal	0 kejadian	Tidak ada kejadian infeksi pada pasien yang disebabkan oleh staf	
7.	Melaksanakan program PKRS						
1)	Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Meningkatkan pemahaman,	1) Keluarga pasien	Internal	100%	Form Edukasi Terintegrasi	



		keterlibatan keluarga	ICU 2) PIC PKRS				
2)	Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas mengenai kesehatan	1) Keluarga pasien ICU 2) PIC PKRS	Internal	8x/bln	Form Edukasi Kelompok	
3)	Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai macam penyakit dan pencegahannya	1) PIC PRKS 2) Seluruh staf ICU	Internal	1 bulan sekali	Video Edukasi	
4)	Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. ICU	Memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dan edukasi keluarga pasien berjalan optimal	1) Staf ICU 2) PIC PKRS	Internal	Seminggu 2x	Adanya Video, Leaflet, Poster	
8.	Melaksanakan MONEV						
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk	Memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan	Kepala Ruang	Internal	Supervisi : Setiap hari Evaluasi : 1 bulan sekali	Laporan Supervisi dan Evaluasi Kinerja	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam satu unit kerja.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat unit	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit,	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat koordinasi	

	manajemen, program	meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam kinerja.					
9.	Membuat laporan						
1)	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu bulan.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Laporan bulanan	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Meningkatkan SDM ICU						
1)	Menghitung Kebutuhan SDM	1. Melakukan perhitungan sesuai rumus 2. Membandingkan kenyataan / existing dengan perhitungan	Lembar perhitungan staf	Spread sheet	Sesuai SDM	Rekrutmen	
2)	Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru	1. Melakukan supervisi SPO unit yang telah di berikan 2. Melakukan penilaian tindakan yang telah dilakukan	Lembar penilaian staf orientasi	Spread sheet	Sesuai SDM	Laporan Penilaian Staf Orientasi	
3)	Membuat penilaian Kinerja Staf	Melakukan pencatatan penilaian kinerja staf	Lembar Penilaian Kinerja	Spread sheet	Sebulan sekali	Laporan Penilaian Kinerja	
4)	Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (Mengikuti SDM)	1. Membuat usulan ke SDM kebutuhan Diklat 1 th	Pelatihan/ diklat	Mengisi Form di SIMRS	Sesuai SDM	Sertifikat	
5)	Melaksanakan Diklat ICU (Mengirimkan 2 staf ke RSSA)	2. Melaksanakan panggilan Diklat					



2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien ICU						
1)	Melakukan Personal Higiene	Melakukan seka tiap hari	SOP Personal Hygiene	Pasien	Setiap hari	CPPT	
2)	Melakukan Asuhan Pasien	Melakukan asuhan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien	SOP	Pasien	Setiap hari	CPPT	
3)	Melakukan Tindakan Kegawatan di ICU	Melakukan asuhan pasien sesuai dengan kegawatan pasien	SOP	Pasien	Setiap hari	CPPT	
4)	Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Melakukan edukasi ke keluarga pasien	Leaflet	Keluarga pasien	Setiap hari	Form Edukasi	
5)	Melakukan Pelayanan Psiko, Culturo Spiritual	Melakukan pelayanan kepada pasien untuk spiritual	RPR	Keluarga pasien	2x/minggu	Form RPR	
3	Pengembangan Pelayanan						
1)	Ruang tunggu Khusus Keluarga pasien ICU dilengkapi dengan speaker portable	Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Umum	Form Pengajuan	Internal	Terpenuhi	Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman khusus untuk keluarga pasien ICU	
4	Melaksanakan MFK-K3						
1)	Melaksanakan Pemeliharaan sarana ICU (Bangunan)	Koordinasi dengan IPSRS dan PJ Alat Medis	Supervise	Lembar ceklist	Untuk pemeliharaan dilakukan selama 1 bulan sekali	Hasil supervise Laporan	
2)	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana ICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi aldok/alkes	Koordinasi dengan IPSRS dan PJ Alat Medis	Supervise	Lembar ceklist	Untuk pemeliharaan dilakukan selama 1 bulan sekali dan kalibrasi dilakukan selama 1 tahun sekali	Hasil supervise Laporan	



3)	Melaksanakan Penambahan alat baru	Koordinasi dengan Karu, Kabid untuk pengadaan alat baru	Form Pengadaan alat baru	Form Pengajuan	Sesuai kebutuhan	Adanya alat baru	
4)	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Melakukan MCU	Koordinasi dengan Komite K3 dan PIC Unit	a) Supervise b) Form MCU	a) Lembar ceklist b) Poli MCU	a) Setiap hari b) Setiap 1 tahun sekali	a) Hasil supervise b) Laporan hasil MCU	
5.	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di ICU (PMKP)						
1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a) Kepatuhan Identifikasi Pasien b) Kepatuhan Kebersihan Tangan c) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh d) Kepatuhan Visite Dokter Spesialis (07.00 – 14.00) e) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu INM	Supervisi	Spread sheet SIMRS	Dilakukan penginputan oleh Pulta setiap hari dan di validasi oleh Karu setiap hari	1. Laporan 2. Supervisi	
2)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas RS kepatuhan pada semua indicator SKP a) Identifikasi Pasien Dengan Benar b) Komunikasi Efektif	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu SKP	Supervisi	Spread sheet SIMRS	Dilakukan penginputan oleh Pulta setiap hari dan di validasi oleh	1. Laporan 2. Supervisi	



	c) Peningkatan Keamananobat Yang Perlu Diwaspadai d) Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Dan Pasien Yang Menjalani Tindakan Dan Prosedur e) Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan f) Pengurangan Resiko Jatuh				Karu setiap hari		
3)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit : a) Angka Pasien Kembali Ke Perawatan Intensive Dengan Kasus Yang Sama < 72 jam b) Kepatuhan Pengisian Pengkajian Form Kriteria Keluar Masuk ICU Pada Pasien ICU c) Kepatuhan Perawat Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu Unit	Supervisi	Spread sheet SIMRS	Dilakukan penginputan oleh Pulta setiap hari dan di validasi oleh Karu setiap hari	1. Laporan 2. Supervisi	
6.	Melaksanakan program PPI di ICU						
1)	Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis	Koodinasi dan melakukan supervisi terkait PPI	Supervisi	Spread sheet	Setiap hari	Laporan	



	e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus						
2)	Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Koodinasi dan melakukan supervisi terkait PPI	Supervisi	Spread sheet	Setiap hari	Laporan	
7.	Melaksanakan program PKRS						
1)	Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Melakukan edukasi setiap hari kepada pasien dan keluarga	Form Edukasi	SIMRS	Setiap hari	Form kebutuhan edukasi	
2)	Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Melakukan edukasi kepada penunjang kelompok	Leaflet	Link Laporan Edukasi	8x/bulan	Form Edukasi Kelompok	
3)	Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Melakukan Edukasi kepada Masyarakat	Radio RS	Laporan	1x/bulan	Form Edukasi	
4)	Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. ICU	Melakukan pengelolaan media edukasi	Form Pengadaan	Form	1x/bulan	Adanya Media Edukasi	
8.	Melaksanakan MONEV						
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk	Melakukan monitoring supervisi dan evaluasi	Supervisi Evaluasi	Spread sheet	1) Setiap hari 2) 1x/bulan	1) Setiap hari 2) 1x/bulan	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Melakukan rapat unit	Umandok	Laporan	1x/bulan	Setiap 1 bulan sekali	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program	Melakukan rapat koordinasi antar unit, manajemen, program	Umandok	Laporan	1x/bulan	Setiap 1 bulan sekali	
9	Membuat laporan						
1)	Membuat laporan bulanan	Melakukan pembuatan	Laporan	Laporan	1 bulan	Laporan bulanan dan	

	(bulanan, tahunan)	laporan bulanan dan tahunan			sekali dan 1 tahun sekali	laporan tahunan	
--	--------------------	-----------------------------	--	--	---------------------------	-----------------	--

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan disesuaikan jadwal di atas

No	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Meningkatkan SDM ICU																	
1)	Menghitung Kebutuhan SDM	1. SDM 2. Staff ICU													ICU	Karu	PT.DPM	
2)	Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru		Sesuai SDM												ICU	Karu	PT.DPM	
3)	Membuat penilaian Kinerja staf														ICU	Karu	RS	
4)	Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM)														R. Diklat	SDM	PT.DPM	
5)	Melaksanakan Diklat ICU (mengirimkan 2 staf ke RSSA)														RSSA	SDM	PT.DPM	
2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien ICU																	
1)	Melakukan Personal Higiene	Seluruh pasien pasien ICU													R. ICU	Seluruh Staf ICU	RS	
2)	Melakukan Asuhan Pasien	Seluruh pasien pasien ICU																
3)	Melakukan Tindakan Kegawatan di ICU	Seluruh pasien pasien ICU																
4)	Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Seluruh keluarga pasien ICU																
5)	Melakukan Pelayanan Psiko, Culturo Spiritual	Seluruh pasien pasien ICU																
3	Pengembangan Pelayanan																	
1)	Ruang tunggu Khusus Keluarga pasien ICU dilengkapi dengan speaker portable	Penunggu pasien ICU													R. Tunggu ICU	Kabid Pelayanan Kabid	PT.DPM	



																	Umum		
4	Melaksanakan MFK-K3																		
1)	Melaksanakan Pemeliharaan sarana ICU (Bangunan)	Tukang															R. ICU	Karu ICU Kabid Umum	PT.DPM
2)	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana ICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi aldok/alkes	IPSRS Pihak Ketiga															R. ICU	PIC Alat Unit Kabid Umum	RS
3)	Melaksanakan Penambahan alat baru	IPSRS Gudang Farmasi															R.ICU	IPSRS Pengadaan PT	RS
4)	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Melakukan MCU	Seluruh staf ICU															R.ICU	PIC K3RS Komite K3RS	RS
5.	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di ICU (PMKP)																		
1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) a) Kepatuhan Identifikasi Pasien b) Kepatuhan Kebersihan Tangan c) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh d) Kepatuhan Visite Dokter Spesialis (07.00 – 14.00) e) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Seluruh staf ICU															R.ICU	PIC Mutu Komite Mutu	RS



2)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas RS kepatuhan pada semua indicator SKP a) Identifikasi Pasien Dengan Benar b) Komunikasi Efektif c) Peningkatan Keamananobat Yang Perlu Diwaspadai d) Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Dan Pasien Yang Menjalani Tindakan Dan Prosedur e) Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan f) Pengurangan Resiko Jatuh	Seluruh staf ICU													R.ICU	PIC Mutu Komite Mutu	RS	
3)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit : a) Angka Pasien Kembali Ke Perawatan Intensive Dengan Kasus Yang Sama < 72 jam b) Kepatuhan Pengisian Pengkajian Form Kriteria Keluar Masuk ICU Pada Pasien ICU c) Kepatuhan Perawat Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Seluruh staf ICU													R.ICU	PIC Mutu Komite Mutu	RS	
6.	Melaksanakan program PPI di ICU																	
1)	Melaksanakan Kewaspadaan standard	Seluruh staf ICU													R.ICU	PIC PPI Komite PPI	RS	



	a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus																		
2)	Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Seluruh staf ICU														R. ICU	PIC PPI Komite PPI	RS	
7. Melaksanakan program PKRS																			
1)	Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Seluruh pasien dan keluarga ICU														R. ICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
2)	Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Seluruh keluarga pasien ICU														R. ICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
3)	Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Seluruh keluarga pasien ICU														R. ICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
4)	Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. ICU	Seluruh keluarga pasien ICU														R. ICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS	
8. Melaksanakan MONEV																			
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk	Kepala Ruang ICU														R. ICU	Karu ICU	RS	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Kepala Ruang ICU														R. ICU	Karu ICU	RS	



3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program	Kepala ICU Ruang														R.ICU	Karu ICU	RS	
9	Membuat laporan																		
1)	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Kepala ICU Ruang														R.ICU	Karu ICU	RS	

3.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT.DPM dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5 Kebutuhan Anggaran

No	Nama Alat	Stok Unit	Pengajuan	UtilitasRata ² / Bulan	Harga @Alat	Total
1	Syringepump	12	5 buah	30x/bulan	Rp. 30.000.000	Rp. 150.000.000
2	Infused Pump	5	4 buah	30x/bulan	Rp. 30.000.000	Rp. 120.000.000
3	Monitor	5	5 buah	30x/bulan	Rp. 30.000.000	Rp. 150.000.000
4	Set Oral Hygiene	0	3 buah	30x/bulan	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
5	Troli Baskom Seka pasien (Stainless)	0	2 buah	30x/bulan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
					TOTAL	Rp.422.500.000

Tabel 3.6 Kebutuhan Anggaran Biaya Pengembangan dan Diklat

No	Kegiatan	Internal/ Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan internal dipelayanan ICU	Internal	12 orang	Rp. 10.000	Rp. 720.000
2	Pelatihan ICU Dasar	Eksternal	3 orang	Rp. 17.000.000	Rp. 51.000.000
3	Seminar Advance Airway Management	Eksternal	3 orang	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
4	Seminar Mechanical Ventilator For Critical Nurse	Eksternal	3 orang	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
				TOTAL	Rp 60.720.000

Tabel 3.7 Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Unit

No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kegiatan		Target Pelaksanaan	Unit Pelaksana
			Kalibrasi	Uji Kelayakan/ Uji Kebersihan		
1	Syringpump	12	√		Agustus 2026	IPSRS
2	Oximeter	1	√		Agustus 2026	IPSRS
3	Ventilator Mekanik	8	√		Agustus 2026	IPSRS
4	Monitor	13	√		Agustus 2026	IPSRS
5	Infuspump	6	√		Agustus 2026	IPSRS
6	EKG	1	√		Agustus 2026	IPSRS
7	Thermometer	1	√		Agustus 2026	IPSRS
8	HFNC	1	√		Agustus 2026	IPSRS
9	Defibrilator	1	√		Agustus 2026	IPSRS
10	GDA	1		√	Setiap bulan	Laboratorium

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan oleh kepala ruang maupun kepala instalasi berupa supervise secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan setiap hari, minggu, bulan dan tahun sesuai dengan target dari kegiatan unit. Dari hasil monitoring menghasilkan suatu kesimpulan yang akan di evaluasi secara bersamaan disetiap rapat koordinasi dengan kepala bidang dan direkur.



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Jadwal kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi jadwal kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala instalasi intensive care unit Rumah Sakit Prima Husada.

Laporan evaluasi jadwal kegiatan dibuat setiap satu tahun sekali, dibuat dalam bentuk laporan dan ditujukan kepada Direktur RS Prima Husada.

BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja unit ICU disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Pasuruan, 24 November 2025

Mengetahui;

Kepala Instalasi Intensive Care Unit



dr. Robby, Sp.An-Ti

Kepala Ruang ICU



Debi Firmanasia, Amd. Kep

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep